

Auto-sondage intermittent (ISC)

WARWIKI

Information pour le patient · Vider la vessie vous-même avec une sonde fine

L'auto-sondage intermittent (ASI) consiste à vider la vessie en introduisant vous-même une sonde fine et souple, en drainant l'urine, puis en la retirant — quelques fois par jour. Il est utilisé lorsque la vessie ne se vide pas correctement seule. Une fois appris, cela ne prend que quelques minutes, vous offre de la liberté et protège vos reins.

Pourquoi le faire

Si la vessie ne se vide pas complètement — après certaines chirurgies, en cas de **vessie neurologique**, de prolapsus ou d'obstruction — l'urine résiduelle peut provoquer des infections, des fuites et une pression nuisible aux reins. L'ASI **vide complètement la vessie** selon un horaire régulier, évitant ces complications.

Avantages par rapport à une sonde permanente

- **Moins d'infections** qu'une sonde à demeure
- **Pas de poche** et plus de liberté — rien d'attaché entre les sondages
- Meilleure protection à long terme de la vessie et des reins

Cela peut sembler difficile au début, mais la plupart des personnes — et des soignants — l'apprennent rapidement avec l'aide d'une infirmière.

COMPRENDRE LES TERMES

ASI

Auto-sondage intermittent — vider la vessie soi-même, puis retirer la sonde.

Sonde

Un fin tube souple introduit dans la vessie pour drainer l'urine.

Résidu post-mictionnel

L'urine qui reste dans la vessie après avoir uriné.

Vessie neurologique

Vessie dont le fonctionnement est altéré par une atteinte nerveuse.

Technique propre

Se laver les mains et nettoyer la zone — propre, mais non stérile.

Sonde à demeure

Sonde laissée en place avec une poche (ce que l'ASI permet d'éviter).

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? En général non — la plupart des personnes ressentent seulement une légère pression. Les sondes modernes sont pré-lubrifiées et très fines. Il peut y avoir un léger inconfort ou quelques gouttes de sang les premières fois. Une infirmière vous guide pas à pas jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise.

Comment procéder (technique propre)

- 1 **Lavez-vous les mains** et préparez votre matériel ; nettoyez l'orifice.
- 2 **Introduisez doucement** la sonde lubrifiée jusqu'à l'écoulement d'urine ; avancez légèrement encore.
- 3 Laissez la vessie se **vider complètement**, puis retirez la sonde lentement.
- 4 **Jetez** les sondes à usage unique (ou nettoyez les sondes réutilisables selon les instructions) et lavez-vous les mains.

Fréquence

- En général **toutes les 4 à 6 heures** (environ 4 à 6 fois par jour) — votre équipe fixe votre calendrier.
- Ne sautez pas de sondage — un horaire régulier prévient le remplissage excessif et les infections.
- Buvez normalement ; notez les volumes si on vous le demande.

Bon à savoir

- Le sondage peut se faire dans n'importe quelle salle de bain propre ; le matériel est discret et portable.
- Une légère turbidité ou la présence de bactéries est courante — les infections urinaires ne sont traitées que si vous avez des **symptômes**.
- Un soignant peut apprendre à le faire si vous ne pouvez pas le faire vous-même.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Vous **ne pouvez pas introduire la sonde**, ou obtenez peu ou pas d'urine malgré une sensation de plénitude
- Fièvre, frissons ou douleur dorsale/lombaire (possible infection)
- **Saignement** persistant ou douleur importante

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'ASI vide une vessie qui ne se vide pas seule — protégeant vos reins et prévenant infections et fuites.
2. Utilisez la technique propre selon un horaire régulier (souvent toutes les 4 à 6 heures) ; une infirmière vous apprendra jusqu'à ce que ce soit facile.
3. C'est généralement indolore et plus sûr qu'une sonde à demeure. Appelez si vous ne pouvez pas passer la sonde, vider la vessie, ou si vous avez de la fièvre.